Troubles des conduites alimentaires

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Troubles des conduites alimentaires

40.3 Cadre général : classification DSM-5-TR, épidémiologie, repérage

DÉFINITIONS

- **DSM-5-TR** : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, texte révisé (American Psychiatric Association, 2022) : classification utilisée en recherche et en…
- **Changements du DSM-5 (2013)** : aménorrhée retirée des critères de l'anorexie mentale ; hyperphagie boulimique devenue un trouble à part entière ; création de l'ARFID
- **Trouble des conduites alimentaires (TCA)** : perturbation persistante de l'alimentation ou du comportement alimentaire qui retentit sur la santé physique ou la vie sociale, ce qui la distingue d'un comportement…
- **Crise de boulimie** : ingestion, en un temps limité (par exemple moins de 2 heures), d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient, avec un…
- **Comportement compensatoire** : vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques ou autres médicaments, jeûne ou exercice physique excessif, destinés à éviter la prise de poids
- **ARFID** : trouble de l'alimentation sélective et évitante : restriction ou évitement entraînant perte de poids, carence, dépendance à des compléments ou gêne sociale, sans…
- **Pica** : ingestion répétée, pendant au moins 1 mois, de substances non nutritives (terre, craie, glace, papier), inappropriée au stade de développement ; rechercher une carence…
- **Mérycisme** : régurgitations répétées d'aliments, remâchés, ravalés ou recrachés, sans cause digestive ; à distinguer du reflux gastro-œsophagien
- **Autres TCA spécifiés** : anorexie mentale atypique (tous les critères, poids normal malgré une perte importante), boulimie ou hyperphagie de faible fréquence ou de courte durée, trouble purgatif…
- **TCA non spécifiés** : trouble alimentaire cliniquement significatif dont le clinicien ne précise pas la forme
- **Orthorexie, bigorexie** : obsession de manger « sain » ; dysmorphie musculaire : ce ne sont pas des diagnostics du DSM-5-TR
- **SCOFF-F** : questionnaire de repérage des TCA en 5 questions fermées (vomissements, perte de contrôle, perte de plus de 6 kg en 3 mois, se trouver trop gros, nourriture qui domine…

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence vie entière (Hudson 2007), femmes / hommes** : anorexie 0,9 % / 0,3 % ; boulimie 1,5 % / 0,5 % ; hyperphagie boulimique 3,5 % / 2,0 %
- **SCOFF-F positif** : ≥ 2 réponses positives sur 5

40.3.1 Les conduites addictives : définitions et trouble de l'usage

DÉFINITIONS

- **Substance psychoactive** : substance qui modifie le fonctionnement du cerveau (perceptions, humeur, conscience, comportement) : alcool, nicotine, cannabis, opioïdes, cocaïne, amphétamines,...
- **Addiction** : perte de contrôle d'un comportement de consommation poursuivi malgré ses conséquences négatives
- **Usage simple** : usage à faible risque, sans dommage
- **Mésusage** : usage à risque (expose à des dommages sans en avoir encore causé : au-delà des repères, conduite après avoir bu, grossesse) ou usage nocif (dommages physiques,...
- **Dépendance** : perte de contrôle, craving, tolérance et syndrome de sevrage
- **Tolérance** : diminution de l'effet d'une même dose, qui pousse à augmenter les quantités
- **Sevrage** : ensemble de signes physiques et psychiques qui apparaissent à l'arrêt ou à la diminution de la consommation
- **Craving** : envie impérieuse, irrépressible, de consommer une substance
- **Trouble de l'usage d'une substance (DSM-5-TR)** : mode d'usage problématique avec altération du fonctionnement ou souffrance, défini par au moins 2 des 11 critères sur 12 mois : perte de contrôle (1 à 4), altération...
- **Circuit de la récompense** : voie dopaminergique (aire tegmentale ventrale vers noyau accumbens) activée par les substances ; le cortex préfrontal, moins efficace, ne freine plus la consommation :...

VALEURS REPÈRES

- **Gravité du trouble de l'usage** : léger 2-3 critères ; modéré 4-5 ; sévère ≥ 6
- **Décès attribuables (2015)** : alcool ≈ 41 000 par an ; tabac ≈ 75 000 par an

40.3.1 L'alcool : verre standard, alcoolémie, repérage, sevrage

DÉFINITIONS

- **Verre standard** : quantité de boisson alcoolisée contenant environ 10 g d'alcool pur (25 cl de bière à 5 %, 10 cl de vin à 12 %, 3 cl de whisky à 40 %)
- **Alcool déshydrogénase (ADH)** : enzyme cytosolique qui oxyde l'éthanol en acétaldéhyde (à ne pas confondre avec l'hormone antidiurétique) ; saturée dès de faibles concentrations, d'où une élimination à...
- **MEOS** : système microsomal d'oxydation de l'éthanol (CYP2E1), inductible
- **ALDH2** : aldéhyde déshydrogénase mitochondriale, qui oxyde l'acétaldéhyde en acétate ; ces oxydations produisent un excès de NADH
- **Alcoolémie** : concentration d'alcool dans le sang, en g/L ; estimée par la formule de Widmark
- **AUDIT** : questionnaire de l'OMS en 10 questions notées de 0 à 4 (score 0 à 40) : questions 1 à 3 consommation, 4 à 6 dépendance, 7 à 10 dommages
- **AUDIT-C** : version courte : les 3 premières questions de l'AUDIT, score sur 12
- **RPIB** : repérage précoce et intervention brève (HAS 2014), recommandés à tous les professionnels de santé, y compris le diététicien
- **Marqueurs biologiques** : GGT (induction enzymatique, normalisation en 2 à 3 semaines d'arrêt), VGM > 100 fL (macrocytose, normalisation en 3 mois environ), ASAT/ALAT > 2, CDT (le plus spécifique...

- **Syndrome de sevrage alcoolique** : 6 à 24 h après la dernière prise : tremblements, sueurs, tachycardie, anxiété, insomnie, nausées ; acte médical (benzodiazépines, hydratation, électrolytes, thiamine)
- **Delirium tremens** : complication grave du sevrage, en général entre le 2e et le 4e jour : confusion, hallucinations, fièvre, déshydratation, agitation ; peut être mortel

FORMULES

- **Alcool pur** : masse (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8 (masse volumique de l'éthanol, g/mL)
- **Verres standard** : nombre = alcool (g) / 10
- **Énergie de l'alcool** : énergie (kcal) = alcool (g) × 7
- **Alcoolémie (Widmark)** : alcoolémie (g/L) = alcool (g) / [poids (kg) × K], K = 0,7 (homme), 0,6 (femme)
- **Durée d'élimination** : durée (h) = alcoolémie (g/L) / vitesse d'élimination (g/L/h)
- **Rapport ASAT/ALAT** : rapport = ASAT / ALAT, évocateur d'une atteinte alcoolique s'il dépasse 2

VALEURS REPÈRES

- **Repères Santé publique France et INCa (2017)** : ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2 verres/jour, des jours sans alcool ; grossesse : zéro alcool
- **Seuils de conduite** : 0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré) ; 0,2 g/L en permis probatoire et pour les conducteurs de transport en commun
- **Élimination de l'alcool** : 0,10 à 0,15 g/L/h
- **AUDIT (HAS)** : mésusage probable ≥ 8 (homme), ≥ 7 (femme) ; dépendance probable > 12
- **AUDIT-C** : positif à partir de 4 (homme), 3 (femme)
- **VGM ; ASAT/ALAT** : > 100 fL (macrocytose) ; > 2

40.3.1 Thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; nutrition de l'alcoolique

DÉFINITIONS

- **Thiamine pyrophosphate (TPP)** : forme active de la vitamine B1, coenzyme de la pyruvate déshydrogénase, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase
- **Encéphalopathie de Gayet-Wernicke** : atteinte cérébrale aiguë par carence en thiamine, souvent déclenchée par un apport de glucose sans thiamine : confusion, ataxie, troubles oculomoteurs (nystagmus) ;...
- **Syndrome de Korsakoff** : amnésie antérograde avec fabulations, séquelle souvent irréversible d'une carence en thiamine non traitée
- **Règle « thiamine avant le glucose »** : chez tout patient alcoolodépendant, dénutri, anorexique ou qui vomit depuis longtemps, la thiamine est donnée avant ou en même temps que le premier apport glucidique
- **Calories vides** : l'alcool apporte de l'énergie (7 kcal/g) sans micronutriments ; carences en B1, B9, magnésium, zinc ; hypoglycémie, stéatose, dénutrition

FORMULES

- **Dose de thiamine du Gayet-Wernicke** : dose (mg/j) = 500 mg × 3 prises, par voie IV
- **Apport protéique du dénutri alcoolique** : protéines (g/j) = poids (kg) × 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Part de l'alcool dans l'apport énergétique** : part (%) = énergie de l'alcool / besoin × 100

VALEURS REPÈRES

- **Réserves de thiamine** : 25 à 30 mg, épuisées en 2 à 3 semaines
- **Thiamine en prévention pendant le sevrage (SFA 2015)** : 250 à 500 mg/j
- **Gayet-Wernicke** : thiamine 500 mg × 3/j IV, avant le glucose ; triade complète dans moins d'un cas sur cinq : traiter au moindre doute

40.3.1 Tabac, cannabis et autres substances

DÉFINITIONS

- **Nicotine** : responsable de la dépendance ; atteint le cerveau en 10 secondes environ ; anorexigène (neurones POMC) et augmente la dépense énergétique
- **Test de Fagerström** : questionnaire en 6 questions (Heatherton et coll., 1991), score de 0 à 10, évaluant la dépendance à la nicotine ; les plus informatives : délai réveil-première cigarette…
- **Paquet-année** : unité d'exposition au tabac : un paquet de 20 cigarettes par jour pendant un an
- **THC et CBD** : Δ9-tétrahydrocannabinol, psychoactif, qui active les récepteurs CB1 (orexigène : fringales) ; cannabidiol, non enivrant
- **Hyperémèse cannabinoïde** : vomissements cycliques incoercibles chez un consommateur chronique quotidien de cannabis, soulagés par les douches ou bains très chauds ; seul traitement efficace :…
- **Autres substances** : cocaïne et amphétamines coupent l'appétit ; opioïdes et traitements de substitution : constipation, attirance pour le sucré, caries

FORMULES

- **Paquets-années** : PA = (cigarettes par jour / 20) × années de tabagisme
- **Score de Fagerström** : somme des points des 6 questions
- **IMC après l'arrêt du tabac** : IMC = (poids + prise) / taille²

VALEURS REPÈRES

- **Fagerström** : 0-2 pas de dépendance ; 3-4 faible ; 5-6 moyenne ; 7-10 forte
- **Prise de poids à l'arrêt du tabac (HAS 2014)** : + 4 à 5 kg en moyenne, surtout la première année
- **Fumeurs quotidiens (18-75 ans, 2022)** : 24,5 %
- **Tabac info service** : 39 89

40.3.2 L'anorexie mentale

DÉFINITIONS

- **Anorexie mentale** : restriction des apports conduisant à un poids significativement bas, peur intense de prendre du poids et altération de la perception du poids ou de la forme du corps ;…
- **Critères DSM-5-TR** : A. restriction et poids significativement bas ; B. peur intense de grossir ou comportement qui empêche la prise de poids ; C. perception du corps altérée, influence…
- **Type restrictif** : perte de poids par régime, jeûne ou exercice excessif, sans crises ni purges récurrentes dans les 3 derniers mois
- **Type avec crises de boulimie et purges** : crises et/ou vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques, lavements dans les 3 derniers mois
- **Syndrome de basse T3** : baisse de la T3 et du tonus sympathique au cours du jeûne : bradycardie, hypothermie

- **Hypogonadisme hypogonadotrope** : chute de la leptine qui supprime la sécrétion pulsatile de GnRH, donc de LH et FSH : aménorrhée
- **Lanugo, acrocyanose** : duvet fin de la dénutrition sévère ; extrémités violacées et froides par vasoconstriction
- **Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)** : chute du phosphore, du potassium et du magnésium et rétention hydrosodée lors de la renutrition d'un patient dénutri, par élévation de l'insuline ; troubles du rythme,...
- **Repas thérapeutique** : repas pris avec un soignant pour assurer les apports et réexposer aux aliments redoutés ; durée limitée (30 à 45 minutes), pas de négociation du contenu

FORMULES

- **IMC** : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
- **Perte de poids** : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Poids pour un IMC cible** : poids cible (kg) = IMC cible × taille²
- **Durée de reprise** : durée (semaines) = poids à reprendre / vitesse de reprise (kg/semaine)
- **Surplus énergétique de la reprise** : surplus (kcal/j) = vitesse (kg/semaine) × 7 000 / 7

VALEURS REPÈRES

- **Gravité DSM-5-TR (adulte, IMC kg/m²)** : légère ≥ 17 ; modérée 16 à 16,99 ; sévère 15 à 15,99 ; extrême < 15 (percentiles chez l'enfant et l'adolescent)
- **Épidémiologie** : début 14 à 17 ans ; SMR ≈ 5,9 (Arcelus 2011) ; évolution ≈ 50 % guérison, 30 % amélioration, 20 % chronicité
- **Hospitalisation HAS 2010, adulte** : IMC < 14 ; perte de 20 % en 3 mois ; FC < 40/min ; PA < 90/60 mm Hg ; T < 35 °C ; K < 3 mmol/L ; P < 0,5 mmol/L ; Na < 125 mmol/L ; glycémie < 0,6 g/L symptomatique (<...
- **Hospitalisation HAS 2010, adolescent** : IMC < 14 après 17 ans, < 13,2 à 15-16 ans, < 12,7 à 13-14 ans ; perte > 2 kg/semaine ; pouls < 40/min ; PA systolique < 80 mm Hg ; T < 35,5 °C ; acétonurie ; glycémie <...
- **Vitesse de reprise (HAS 2010)** : 0,5 à 1 kg/semaine à l'hôpital ; 0,2 à 0,5 kg/semaine en ambulatoire
- **Risque de SRI (NICE 2006)** : IMC < 16 ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls > 10 jours ; P, K ou Mg bas avant la renutrition ; survenue en 2 à 5 jours
- **Énergie de la reprise** : ≈ 7 000 kcal par kg de poids repris
- **Structure des repas ; calcium (ANSES 2021)** : 3 repas et 1 à 3 collations ; 1 150 mg/j de 11 à 17 ans

40.3.3 La boulimie

DÉFINITIONS

- **Boulimie (bulimia nervosa)** : crises de boulimie récurrentes et comportements compensatoires inappropriés, en moyenne au moins une fois par semaine pendant 3 mois, estime de soi dépendante du poids ;...
- **Critère E** : le trouble ne survient pas exclusivement pendant une anorexie mentale : si le poids est significativement bas, le diagnostic est l'anorexie avec crises et purges
- **Alcalose hypochlorémique** : bicarbonates élevés et chlore bas par perte d'acide chlorhydrique (vomissements) ; les laxatifs donnent au contraire une acidose hyperchlorémique
- **Hypokaliémie** : complication la plus dangereuse des purges : troubles du rythme, QT long, mort subite ; K < 3 mmol/L est un critère d'hospitalisation de l'adulte

- **Signe de Russell** : callosités sur le dos de la main dues aux vomissements provoqués ; avec l'hypertrophie des parotides et les érosions dentaires
- **Cycle de la boulimie** : restriction → crise → compensation → culpabilité → nouvelle restriction
- **Œdèmes à l'arrêt des purges** : l'aldostérone, stimulée par la déshydratation chronique, reste élevée : rétention de sodium et d'eau, prise de 1 à 2 kg d'eau à annoncer

FORMULES

- **IMC** : poids / taille²
- **Énergie des crises** : énergie (kcal/semaine) = nombre de crises × énergie par crise
- **Besoin rapporté au poids** : besoin (kcal/kg/j) = besoin / poids

VALEURS REPÈRES

- **Gravité DSM-5-TR (compensations par semaine)** : légère 1 à 3 ; modérée 4 à 7 ; sévère 8 à 13 ; extrême ≥ 14 (Manon, 9 : sévère)
- **Interprétation du ionogramme** : K < 3 mmol/L : urgence ; HCO_3^- > 28 mmol/L avec Cl^- bas : vomissements (Manon : K 2,9, HCO_3^- 33, Cl^- 90 mmol/L) ; HCO_3^- bas avec Cl^- élevé : laxatifs
- **Traitement (HAS 2019)** : TCC en 1re intention ; 3 repas et 1 à 3 collations ; fluoxétine 60 mg/j (AMM boulimie)

40.3.4 L'hyperphagie boulimique

DÉFINITIONS

- **Hyperphagie boulimique (binge eating disorder)** : crises de boulimie récurrentes avec perte de contrôle et détresse marquée, sans comportements compensatoires réguliers ; TCA le plus fréquent, début souvent entre 20 et…
- **Caractéristiques des crises (≥ 3 sur 5)** : manger beaucoup plus vite que la normale ; jusqu'à une distension inconfortable ; de grandes quantités sans faim ; seul par gêne ; dégoût de soi, déprime ou culpabilité…

FORMULES

- **IMC** : poids / taille²
- **Objectif de perte de poids** : perte (kg) = poids × 5 à 10 %

VALEURS REPÈRES

- **Gravité DSM-5-TR (crises par semaine)** : légère 1 à 3 ; modérée 4 à 7 ; sévère 8 à 13 ; extrême ≥ 14 (M. Karim B., 5 : modérée)
- **Fréquence minimale** : au moins 1 crise par semaine pendant 3 mois
- **Lien avec l'obésité** : 20 à 30 % des personnes qui consultent pour une obésité

40.9 et 40.11 Études de cas : calculs corrigés

FORMULES

- **M. Patrick D., 52 ans, 1,78 m, 64 kg (72 kg il y a 6 mois)** : IMC = 64 / 3,1684 = 20,2 ; perte = 8 / 72 = 11,1 % en 6 mois
- **Théo, 19 ans, 1,80 m, 63 kg (68 kg habituellement)** : perte = 5 / 68 = 7,4 % ; IMC = 63 / 3,24 = 19,4
- **Hugo, 17 ans, 1,78 m, 52 kg (63 kg il y a 10 mois)** : perte = 11 / 63 = 17,5 % ; IMC = 52 / 3,1684 = 16,4 ; disponibilité énergétique = (1 800 − 900) / 47 = 19,1 kcal/kg MM/j
- **Mme Claire V., 24 ans, DT1, 1,65 m, 52 kg (58 kg)** : perte = 6 / 58 = 10,3 % ; IMC = 52 / 2,7225 = 19,1

- **Mme Nadia K., enceinte de 10 semaines** : verre de 12 cl à 12 % : 120 × 12 / 100 × 0,8 = 11,52 g ; 6 verres : 69,1 g/semaine
- **Internat, 400 élèves** : SCOFF-F positif : 38 / 400 = 9,5 % ; filles 29 / 210 = 13,8 % ; garçons 9 / 190 = 4,7 %
- **M. Bernard L., 63 ans, cirrhose, 1,72 m, 59 kg** : IMC = 59 / 2,9584 = 19,9 ; 6 verres de 12,5 cl à 12 % = 6 × 12 = 72 g/j ; énergie = 59 × 35 = 2 065 kcal/j ; protéines 71 à 89 g/j
- **Mme Élodie R., 35 ans, 1,63 m, 104 kg** : IMC = 104 / 2,6569 = 39,1 kg/m²
- **Lucie, 20 ans, 58 kg** : 11 verres par semaine dont 8 le samedi ; AUDIT-C 7 ≥ 3 (femme)
- **M. Ahmed S., 45 ans, méthadone, 1,76 m, 82 kg (70 kg)** : prise = 12 / 70 = 17,1 % ; IMC = 82 / 3,0976 = 26,5 ; 1,5 L de soda : 159 g de sucres × 4 = 636 kcal

Les pièges

- « L'aménorrhée est un critère obligatoire du diagnostic d'anorexie mentale. » → faux : Elle a été retirée des critères depuis le DSM-5 (2013), même si elle est fréquente.
- « Dans l'anorexie mentale, la sensation de faim disparaît. » → faux : La faim existe (ghréline élevée) mais elle est niée et combattue.
- « L'hyperphagie boulimique comporte des vomissements provoqués réguliers. » → faux : Elle se définit par l'absence de compensations régulières.
- « Les vomissements répétés provoquent une acidose métabolique. » → faux : Ils provoquent une alcalose hypochlorémique (perte d'HCl) ; ce sont les laxatifs qui provoquent une acidose.
- « Les laxatifs empêchent l'absorption des calories d'une crise. » → faux : L'absorption a lieu dans l'intestin grêle ; les laxatifs agissent sur le côlon et font perdre surtout de l'eau et des électrolytes.
- « Les repères de 2017 autorisent 3 verres par jour pour les hommes. » → faux : Le repère est le même pour tous : 2 verres par jour au maximum, 10 par semaine, pas tous les jours.
- « Chez un alcoolique dénutri, on perfuse d'abord du glucose, puis on donne la thiamine le lendemain. » → faux : La thiamine doit être donnée avant ou avec le glucose, sinon on risque de déclencher un Gayet-Wernicke.
- « La triade confusion, ataxie, troubles oculomoteurs est presque toujours complète dans le Gayet-Wernicke. » → faux : Elle est complète dans moins d'un cas sur cinq : on traite au moindre doute.
- « Un score de Fagerström de 3 indique une dépendance forte. » → faux : 3-4 : dépendance faible ; forte à partir de 7.
- « La leptine est élevée dans l'anorexie mentale. » → faux : Elle s'effondre avec la masse grasse, ce qui freine l'axe gonadotrope.
- « Le syndrome de basse T3 de l'anorexie doit être traité par des hormones thyroïdiennes. » → faux : C'est une adaptation d'économie ; il se corrige avec la renutrition.
- « Dans l'hyperphagie boulimique, il faut commencer par un régime hypocalorique strict. » → faux : La restriction aggrave les crises : on traite les crises d'abord.